

4절. 噎膈열격 및 反胃반위(翻胃반위)

1. 개요

· 열격 음식을 넘기기 힘든 것, 거의 식도문제

음식을 삼킬 때 장애가 있어 식입즉토(食入卽吐)하는 병증. 연하곤란

:증상

- └ 열증(噎症): 呑咽之時탄인지시, 梗噎不順경열불순 → 삼킬 때 잘 안 넘어가는 것
- └ 격증(膈症): 胸膈阻塞흉격조색, 飲食不下음식불하 → 흉격이 막혀있어 음식이 안내려가는 것

· 반위(翻胃반위, 胃反위반)

음식을 삼키긴 하나 한참 지나면 소화되지 않은 음식을 도로 토출(吐出)하는 증상

:증상

脘腹痞脹완복비창, 宿食不化숙식불화, 朝食暮吐조식모토, 暮食朝吐모식조토

· 열격 및 반위 원인 - 음식물이 내려가지 않는 연하곤란과 관련

- 열허, 기허(양허), 유담(有痰), 유열(有熱)

└ 열격: 음허유화(陰虛有火)(진고열결(津枯熱結))로 인한 **식도질환과 관련**

└ 반위: 양허유한(陽虛有寒)(비위허한(脾胃虛寒))으로 인한 **위, 십이지장 질환과 관련**

2. 서양의학적 이해

1) 열격

1. 분류

① 기계적 연하곤란

: 큰 덩어리가 있거나, 내강이 좁아져 발생 [식도 자체가 좁아짐]

→ 식도의 악성종양, 협착, 하부식도질환(lower esophageal mucosal ring)

② 운동성 연하곤란

: 연동운동의 약화/실조, 연하억제에 의해 발생 [연하운동이 안 됨]

→ 인두마비, 윤상 인두근 무이완증, 하부식도괄약근 이완불능증, 미만성 식도경련, 식도의 경피증

→ 신경질환(다발성 뇌경색, 근위축성측삭경화증 등), 근육질환(근육퇴행위축, 피부경화증, 다발근육염 등), 신경근 접합부의 질환(중증 근무력증, 보툴리눔 중독 등)에서도 연하기능 저하로 인한 연하곤란 발생

2. 특징

1) 일시적이면 염증성 의심 / 수주~수개월로 진행 시 식도암 의심

2) 나이 들면 연하곤란이 더 발생 → 쉽게 사려 들리고, 딸꾹질 자주 하게 됨

3. 연하곤란을 일으키는 음식물의 종류

① 기계적 연하곤란

: 고형물에서만 나타나며 심한 것은 아님. 폐쇄 진행 시 액체도 연하곤란

② 운동성 연하곤란

: 고형물/액체에서 같은 양상 ← 연하운동 자체가 안 되니까

✓ 경피증

: 고형물 / 누운 자세에서는 유동식에도 연하곤란

→ 경피증: 피부가 두꺼워지는 것

⇒ 식도 안쪽의 편평상피에도 경피증이 생김 → 연하운동 잘 안 일어남

⇒ ∴서있을 땐 중력 방향으로 내려가므로 괜찮은데, 누우면 움직이지 않으므로

4. 감별 (동반 증상)

- ① 연하 시 비역류, 기관지내 흡인 → 인두마비, 기관식도 누공
- ② 연하와 관계없는 기관내 흡인 → 식도이완불능증, Zenker 게실, 위식도역류 등
- ③ 연하곤란에 비해 심한 체중감소 → 암 의심
- ④ 연하곤란에 앞서 목소리가 쉬는 것 → 일차 병변이 후두에 존재
- ⑤ 연하곤란과 후두증상의 동반 → 여러 신경근육질환에서 보임
- ⑥ 딸꾹질 → 식도하방에 병변
- ⑦ 연하곤란과 동반한 편측성의 천명음 → 식도와 기관지를 침범한 종격동 종양

2) 반위

- 위 십이지장 궤양, 위 십이지장 게실, 급 만성 위염, 위의 악성종양, 위신경증 등
- 위의 유문부* 경련/부종/협착을 유발해 위장의 배출기능장애를 유발하는 질환과 관련
- * 유문부: 위-십이지장 연결 부분 ⇒ 즉 위 → 장으로의 움직임이 안 일어나는 것

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료형

(1) 열격(噎膈)

· 원인

- ① 삼양열결(三陽熱結) (소장열결 즉 혈맥조(血脈燥), 대장열결 즉 불능변(不能便), 방광열결 즉 진액학(津液涸), 전후폐색(前後閉塞), 하기불통(下既不通) 필반이상(必反而上)(내려갈 수 없어 반드시 위로 역상))
- ② 혈허(血虛) (진액구모(津液俱耗), 위완건고(胃脘乾槁), 기고재상(其槁在上), 근인지하(近咽之下))
- ③ 사려상비(思慮傷脾), 기울담결(氣鬱痰結)
- ④ 비신양허(脾腎陽虛)

· 증상

- ㄱ 열: 呑咽之時탄인지시 梗噎不順경열불순 (삼킬 때 잘 안 넘어가고 목이 메임)
- ㄴ 격: 胸膈阻塞흥격조색 飲食不下음식불하
→ 열격: 呑咽困難탄인곤란*, 食未入胃卽吐식미입위즉토*, 水飲可行수음가행*
食物難入식물난입*, 間或可入간혹가입* 入亦不多입역부다*

- * 탄인곤란: 삼키는 게 어려움
- * 식미입위즉토: 먹으면 위에 들어가는 즉시 토함
- * 수음가행 식물난입: 마실 건 들어가는데, 음식물은 들어가기 어려움
- * 간혹가입 입역부다: 간혹 음식물이 들어가지만 많진 않음

· 열격의 삼초 분류

① 상초 (其槁在기고재 賁門분문)

: 食下則胃脘當心而痛, 須臾吐出食出痛乃止

⇒ 음식이 내려가면 위관부 통증이 생기는데, 토해서 음식물이 나오면 통증이 그침

② 중초 (其槁在기고재 幽門유문)

: 或食物可下, 難盡入胃, 良久復出

⇒ 음식물이 밑으로 내려가긴 하는데, 위로 어렵게 들어가고, 얼마 지나지 않아 나옴

③ 하초 (其槁在기고재 蘭門난문)

: 或朝食暮吐, 暮食朝吐

⇒ 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고, 저녁에 먹은 것을 아침에 토함

· 치법: 滋陰潤燥자음윤조 開鬱理氣개울이기

· 치료형

① 실증

치법: 理氣化痰이기화담 開鬱行瘀개울행어

치료형: 膈中단중 巨關거곶 膈愈격수 胃愈위수 足三里족삼리

② 허증

치법: 益血潤燥익혈윤조

치료형: 脾愈비수 氣海기해 膈愈격수 足三里족삼리 公孫공손 勞宮노궁 中脘중완

關元관원 ← 허증이므로 구법을 주로 사용

✓ 식물격거불입(食物格拒不入; 음식물이 안으로 못 들어감): 中脘중괴(灸)*

흉통인배(胸痛引背): 大陵대릉 心俞심수

비색애기(痞塞噎氣): 內關내관 中脘중완

*중괴: 삼초경기를 소통시키고 위기 역상을 회복시켜 구토, 열격을 치료

(2) 반위(反胃)(번위(翻胃))

· 원인

: 脾胃虛寒비위허한, 胃中積熱위중적열, 痰濁阻胃담탁조위,
血虛혈허(血液俱耗혈액구모, 胃脘乾槁위완건고, 其槁在下기고재하, 與胃相近여위상근)

· 증상

: 食後脘腹脹悶식후완복창민, 朝食暮吐조식모토, 暮食朝吐모식조토, 吐食不化토식불화*,
吐後胃脘脹悶輕減토후위완창민경감, 食雖難可入식난가입*, 難盡入胃난진입위*,
良久復出양구부출*, 大便秘少대변비소, 若羊屎然약양시연*

* 토식불화: 소화되지 않은 음식을 토함

* 식난가입: 음식물이 들어가기 어려움

* 난진입위: 위에 진입하기 어려움

* 양구부출: 조금 들어가도 나중에 토함

* 약양시연: (대변을 보더라도) 염소똥처럼 나옴

✓ 교수님은 '食難可入식난가입'으로 읽고 설명하셨는데, 교과서에는

'食雖難可入식수가입'으로 나와있음: 교과서대로 해석하면 '식수가입 난진입위'를 '음식이 비록 들어갈 수 있더라도 위로 진입하기 어렵다' 정도로 해석할 수 있을 것 같습니다

· 치법

: 溫陽健脾온양건비, 降逆和胃강역화위

· 치료혈

: 中脘중완 章門장문 氣海기해 公孫공손 脾俞비수 膻中단중
梁門양문 天樞천추 足三里족삼리

✓ 칠정울결(七情鬱結): 內關내관 建里건리(瀉)

열독옹격(熱毒壅膈): 勞宮노궁(瀉)* 太衝태충(출혈)

정담적음(停痰積飲): 巨闕거궐 水分수분(均瀉均사)

* 노궁: 심포경의 형화혈 ⇒ 사하면 열을 내림

2) 기타치료

(1) 사암침법 (참고)

· 대장열결/소장열결/방광열결/삼초기결로 나누어 치료

제 5절. 위완통

1. 개요

· 위완부(심와부(心窩部) 이하 제부(臍部) 이상의 부위)에서 통증이 발생하는 증후군
· = 심통(心痛), 위통(胃痛), 심위통(心胃痛)

· 검증: 脘腹脹悶완복창민, 惡心오심, 噯腐애부 등(+ 不思飲食불사음식, 吞酸탄산, 嘈雜조잡, 大便或結或瀉대변혹결혹당, 或嘔血便血혹구혈변혈)

· 의서

<황제내경>: 심통은 "胃脘當心而痛위완당심이통"이라 하여 위완통과 동일한 의미로 이해되어 옴

<의학정전>: 胃의 분문과 心이 연락되어 가슴이 아픈 것처럼 느끼는 것. 구종심통이 대부분 위완에서 기인됨

<의학입문>: 심통은 사려상심(思慮傷心)으로 인해, 위완통은 음식상/담음으로 오는것으로 구분

2. 서양의학적 이해

· 급만성 위염, 소화성궤양(위/십이지장궤양), 위암, 기능성 소화불량증, 위하수 및 위신경증 등에서 많이 관찰됨

· 여러 원인으로 위점막이 자극을 받아 평활근이 경련, 위장의 기능이 문란하게 되어 발생

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료혈

· 습곡합곡 太衝태충 內關내관 足三里족삼리 中脘중완 三陰交삼음교

✓ 기통(氣痛): 加 肩髃견우 期門기문 日月일월

정식(停食): 加 梁門양문 天樞천추

위화(胃火): 加 厲兌여태

상랭(傷冷): 加 脾俞비수(灸) 公孫공손

혈어(血瘀): 加 膈俞격수 期門기문

정음(停飲): 加 天樞천추 陰陵泉음릉천

충통(蟲痛): 加 地倉지창 上巨虛상거허 下巨虛하거허

2) 변증치료

(1) 식적위완통(食積胃脘痛)

- 원인: 飲食過多음식과다, 以致積滯이치적체
- 증상: 胃脘痛위완통 噯氣애기 吞酸탄산
- 치법: 健胃消積건위소적
- 치료혈: 足三里족삼리 建里건리 璇璣선기(均瀉군사) 公孫공손 脾俞비수(均補군보)

(2) 담음위완통(痰飲胃脘痛)

- 원인: 胃中流飲清痰위중류음청담
- 증상: 胃脘痛위완통 腹中漉漉有聲복중록록유성 手足寒痛수족한통
或腰膝背脇抽掣作痛 혹은슬배협추체작통(당기는 듯한 통증)
- 치법: 化痰逐飲화담축음
- 치료혈: 巨闕거궐(灸) 水分수분(灸) 豐隆풍릉 三陰交삼음교(均瀉)
✓ 담음 → 거궐·풍릉

(3) 어혈위완통(瘀血胃脘痛)

- 원인: 喜食熱物以致死血留於胃口희식열물이치사혈유어위구
→ 따뜻한 음식 먹기를 좋아하는데, 이게 사혈에 이르러 위구에 머물게 되면 생김
婦人瘀血入心脾부인어혈입심비
- 증상: 心痛심통, 脈澁맥삽, 作時飲湯水下作吃작시음탕수하작홀
→ 더운 물을 마시면 딸꾹질
- 치법: 行血化瘀행혈화어
- 치료혈: 膈俞격수 三陰交삼음교(均瀉) 章門장문(灸)

(4) 간기범위(肝氣犯胃)

- 원인: 肝氣鬱滯간기울체
- 증상: 胃脘脹滿痛위완창만통 痛連兩脇통련양협* 胸悶噯氣흉민애기*
喜(善)太息희(선)태식* 煩惱鬱怒而作痛번뇌울노이작통* 苔薄白태박백 脈弦맥현
甚則痛勢急迫심즉통세급박 心煩易怒심번이노 嘈雜吐酸조잡토산
口乾口苦구건구고 舌紅苔黃脈弦數설홍태황맥현삭
- * 통련양협: 통증이 옆구리까지 감
흉민애기: 가슴 답답, 트림 / 희태식: 한숨 쉬기를 좋아함

번뇌울노이작통: 스트레스 받으면 아픔

- 치법: 疎肝和胃소간화위
- 치료혈: 足三里족삼리(補) 中脘중완(補) 太衝태충(瀉) 內關내관(瀉)
✓ 간기울결 → 주로 태충을 같이 씀

(5) 한사습위(寒邪襲胃)

- 원인: 寒氣凝滯한기응체
- 증상: 胃痛暴作위통폭작 疼痛劇烈동통극렬 畏寒喜暖외한희난 得熱痛減득열통감*
口不渴구불갈 喜熱飲희열음 舌苔白설태백 脈弦緊맥현긴 或弦遲혹현지
- * 득열통감: 따뜻하게 해주면 통증 경감
- 치법: 溫中散寒온중산한
- 치료혈: 中脘중완 關元관원 足三里족삼리(均灸) 胃俞위수(瀉)
✓ 한사로 인한 것 → 통증이 극렬하게 나타남, 위경련과 유사

(6) 위열기울(胃熱氣鬱)

- 원인: 熱結火鬱열결화울, 通降失調통강실조
- 증상: 煩渴欲飲번갈욕음 惡熱喜冷오열희냉 尿赤뇨적 便結변결 苔黃少津태황소진
脈弦數맥현삭 + 열증이 같이 나타남
- 치법: 清熱降火청열강화
- 치료혈: 內關내관 陷谷함곡 厲兌여태(均瀉군사)(위의 정혈 → 사법으로 열을 내려줌)

3) 기타치료(참고)

(1) 사암침법

- 위완통: 위정격(변형)
- 비심통: 비정격(변형)

(2) 부항

- 허한성 위완통에 침자극 후, 상복부와 배부에 발화관법(拔火罐法)을 시술
- +) 내장질환에 배수혈 부항해주면 좋음

제 6절. 腹痛복통

1. 개요

복부(위완 이하부터 치골모제(恥骨毛際) 이상의 부위)에서 발생하는 동통
한의학에서는 원인, 허실, 부위에 따라 구분하여 치료

· 원인

: 식적, 충적(蟲積; 기생충), 욱음, 기혈허허, 기체혈어 등

· 부위에 따른 구분

- ① 상·중·하초 복통
- ② 대(大)·제(臍)·소(小)복통

2. 서양의학적 이해

ㄱ

① 내장성 통증(visceral pain)

: 내장장기*에서 오는 통증 *내장장기: luminal organ: 소화관, 요로 등, '臍'의 개념

· 기전

: 내장장기의 민무늬근에 연축, 신전, 확장, 견인 등의 기계적 자극이 발생하거나,
통증유발 물질 등으로 인해 벽 내에 화학적 자극을 받을 때 생김
ex) 간, 이자(췌장), 신장 등 실질장기의 피막자극에 의한 통증

· 원인

: 염증, 폐쇄(내장장기), 장기의 종창(실질장기) 등

· 통증의 특징

- 둔한 통증 (웬지 배가 아픈듯함)
- 정중선상, 비국한성 (상복부, 배꼽주위, 하복부 중앙의 불명확한 통증)
- 간헐성, 산통 (통증이 간헐적)
- 통증 부위: 이환된 장기의 dermatome과 대략 일치
- 통증의 성상: 일반적으로 경련성이나 작열감, 쪼아내는 듯함
- 이차적인 자율신경증상(발한, 불안, 오심, 구토, 창백 등) 동반 흔함

② 벽측 동통(parietal pain) 혹은 체성통(somatic pain)

: 복막에서 오는 통증

· 기전

: 벽측 복막/창자간막에 염증, 견인, 마찰, 꼬임, 통증유발 물질 등의 물리,
화학적 자극으로 발생 ex) 복막염

· 통증의 특징

- 날카로운 통증 (찌르는 듯한 통증)
- 국한성 (아픈 곳을 정확하게 가리킴)
- 지속성 (통증이 계속됨)
- 일반적으로 내장성 통증보다 강도 심함
- 대개 움직임이나 기침으로 악화됨

③ 연관통(referred pain) (=방사통, 투사통)

· 기전

: 장기의 통증을 전달하는 신경이 피부의 통증을 전달하는 신경과 합류되기 때문에
장기의 통증을 피부의 통증으로 느낌

- ✓ 피부 쪽으로 나타나는 통증이므로, 장기·피부·신경이 같이 지배되는 부위에 나타남
→ 배수혈 부위에 부항으로 피부자극만 주더라도 내장에 영향 ○

· 통증의 특징

- 이환된 장기와 같은 신경절의 지배를 받는 원격부위에서 통증 발생
- 피부나 심부에서 통증
- 정확한 위치 가리킴
- 내장의 유해자극이 심해질 때 나타남

· 연관통 예시 부위

- 협심증: 드물게 통증이 턱쪽으로 옴
- 심장: 견갑 내측
- 위: 등 한가운데

연관통이 심해도 병변이 크지 않을 수 있고, 병변이 커도 연관통이 나타나지 않을 수 있음!

④ 정리

- 복통은 내장성 통증에서 시작되는 경우가 많고, 내장성 통증은 체성 통증으로 이행함
→ 체성 통증이 있으면 복막자극 증상을 고려
→ 복막자극 증상이 나타나면 수술적 처치를 고려

2) 복통의 구분과 원인 복통은 여러 질환에서 유발될 수 있는 일종의 증후군임

(1) 구분

① 복부에서 기원한 통증

- 복강내 장기의 염증성 질환 (급성 위장염 및 대·소장염, 궤장염 등)
- 급성 충수돌기염 또는 소화성 궤양으로 인한 천공으로 세균 오염이나 화학적 자극에 의해 발생하는 벽측 복막의 염증
- 내장의 기계적 폐쇄 (장폐색증, 담도폐색)
- 복부혈관의 장애, 복벽의 이상 등

② 복부 이외의 원인에 의한 연관통

- 생식기, 척추, 흉곽 질환

③ 대사성 또는 신경성 원인에 의한 통증

- 대사성 원인: 외부 요인으로 인한 독소의 중독, 내부 요인으로 인한 요독증 등
- 신경성 원인: 신경의 기질적/기능적 이상으로 유발됨

④ 기타: 일부 심장질환에서도 유발 가능

- 응급수술이 필요한 경우(장폐색증, 천공성 질병 등)도 있으므로 조기에 정확한 감별진단 필요

(2) 구분별 원인

① 복부에서 유발된 통증

1. 벽측 복막염

- ① 세균오염 (ex. 충수염천공, 골반염 질환)
- ② 화학적 자극 (ex. 궤양천공, 궤장염)

2. 중공내장의 기계적 폐쇄

- ① 소장 혹은 대장 폐쇄
- ② 담관폐쇄
- ③ 요관폐쇄

3. 혈관장애

- ① 색전증 혹은 혈전증
- ② 혈관파열
- ③ 압박성 혹은 염전(꼬여서) 폐쇄
- ④ 겸상혈구성 빈혈(sickle cell anemia)

4. 복벽

- ① 장간막염좌 혹은 견인
- ② 근육손상 혹은 감염

5. 장기표면의 팽창 (ex. 간 혹은 신장피막)

② 복부 이외 부위로부터의 연관통

1. 흉부 (ex. 폐렴(→횡격막까지 염증 →복통), 관상동맥폐쇄에 의한 연관통)
2. 척추 (ex. 신경근염)
3. 생식기관 (ex. 고환염전)

③ 대사성 원인

1. 외인성

- ① 거미에 물림(black widow spider) ② 납중독증(lead poisoning)

2. 내인성

- ① 요독증(uremia): 신장 기능의 문제로 노폐물이 제대로 배출되지 않아 생긴 독소로 발생
- ② 당뇨병성 케톤혈증(diabetic ketoacidosis)

- ③ 포르피리아(porphyria): 헴(헤모글로빈 구성 성분)이 잘 안 만들어져 포르피린이 몸에 축적 → 불안·초조, 심리/행동 변화, 구토·변비를 동반하는 복통, 광과민성(햇빛을 싫어하게 됨)
- ④ 알레르기성 인자(C1 esterase 억제인자) 결핍증

④ 신경성 원인

1. 기질적
 - ① 척수로(tabes dorsalis) ② 대상포진(herpes zoster) ③ 작열통(causalgia)
2. 기능적

3) 복통의 고려사항

(1) 통증 지속기간

- 간헐적인 통증: 내장장기의 질환 (만무늬근의 연속으로 인함)
 - ex. 장폐색증, 담석증, 요관결석, 위십이지장궤양 등
- 지속되는 통증: 실질장기, 혹은 복막의 질환
 - 시간이 경과함에 따라 심해지는 복통은 대부분 외과 치료를 요함
- 일정한 통증: 염증이 대부분 (ex. 간염, 췌장염 등)
- 심해지는 통증: 복막자극이나 염증의 파급 등
 - 장기의 파열, 출혈 → 복막의 자극 or 천공 → 복막의 자극, 복막염
- 혈류 장애: 심근경색에서 나타나는 통증과 유사함

(2) 식사와의 관련

- 공복 시의 통증: 십이지장궤양 고려 (산분비 증가로 인해)
- 식사 30~40분 후의 통증: 위궤양 고려 (음식물이 위벽자극)
- 식사 몇 시간 후의 통증: 간, 담도, 췌장 질환 고려 (폭음, 폭식 후 증가)
- 폭음, 폭식, 지방식 → 담석증 (∵ 지방을 소화시킬 때 쓸개즙이 도와주므로)
- 폭음, 폭식, 지방식, 알코올 → 급성 췌장염

(3) 복통의 통증부위

- ① 명치 부위(epigastric region)
 - 위의 질환 이외에도, 심혈관 질환(ex. 협심증), 충수염초기(초기에 명치부위가 아프며, 점차 통증이 우하복부로 이동)에도 나타남
- ② 우측 상복부
 - 간질환, 담낭염, 요로감염증
 - 드물게 폐렴, 늑막염 등으로 가로막이 자극받아 나타날 수 있음
- ③ 좌측 상복부: 이자(췌장), 비장, 가로막, 심장, 요로 질환 등
- ④ 우측 하복부: 돌막창자부분(회맹부, ileocecal portion), 부인과, 요로계 질환 등
- ⑤ 배꼽 주위 (복부 정중앙)
 - 막창자꼬리염(충수염), 혈관의 병(대동맥류 파열, 장간막동정맥 혈전증)
- ⑥ 좌측 하복부 → 대부분 대장 끝 부분(S자 결장 등)
 - 부인과 질환, 요로계 질환, 구불창자꼬임(S자결장 염전), 구불창자 결주머니염(S자결장 게실염), 궤양궤궤창자염(궤양성대장염, ulcerative colitis) 등

4) 복통의 진단

(1) 병력청취(문진)

- ① 위치
 - 식도: 자극부위에서 통증, 심하면 등 가운데에 연관통
 - 위, 십이지장: 상복부 중앙, 십이지장이 굽는 상복부 우측 등으로 방사
 - 소장: 배꼽주위 중앙 복부, 등쪽에서 방사
 - 회장: 하복부나 우측 / 결장: 하복부
 - 담낭, 총담관: 상복부 중앙, 우상복부, 견갑골부위 등쪽으로 연관통(대부분 우측)
 - 췌장: 중심선, 좌측 상복부, 등쪽 중앙의 연관통
 - 췌미부 염증에 의한 좌측 횡격막 자극으로 왼쪽어깨로도 통증 (굉장히 드뭄)
 - 골반내 기관: 하복부
- ② 강도와 성상
 - 통증의 강도와 유해성 자극의 정도는 반드시 일치하지는 않음
 - 특징적 양상: 궤양 – 쪼아내는 듯함(grow) / 파열된 동맥류 – 찢는 듯한(tearing) 통증

· ③ 기간

- 6시간 이상 지속하는 급성복통은 대개 수술적 치료를 요함

· ④ 악화 혹은 완화인자

- 척수신경근에서 기인: 기침, 재채기, 배에 힘줄 때 심해짐 ex) 늑간신경염
- 원위부 대장: 배변 후 경감되는 경우 많음 / 담낭통: 지방식 섭취로 악화
- 소화성궤양의 복통: 음식, 제산제의 섭취로 경감 (제산제 → 산이 희석됨 → 통증 ↓)
- 급성 복막염, 급성 심근경색: 똑바로 움직이지 않고 누워있을 때 감소
- 급성 췌장염: 앉거나 허리를 앞으로 굽힐 때 감소

· ⑤ 동반된 징후 증상 상태

- 소화기능의 변화(체중감소, 식욕부진, 오심, 구토 등), 황달, 배뇨 혹은 배변습관의 변화, 부인과적 기능의 변화, 임신 등

(2) 망진 – 팽창, 반흔, 탈장, 연동 항진 등

- 수술 후 반흔: 장폐색
- 연동운동 과다: 기계적 장폐색
- 출혈반: 중증 급성 췌장염, 외상, 자궁외임신 등 고려
- (3) 청진 – 장관운동음의 양상과 빈도
- 아무 소리도 들리지 않으면 → 마비성 장폐색 (안 움직이는 것)
- 장관잡음이 증가해 금속음이 들리면 → 기계적 장폐색 (해결을 위해 장이 막 움직이면서 오히려 소리가 증가)
- (4) 타진 – 복부내의 가스 증가로 인한 고창
- (5) 촉진 – 강직, 종괴, 압통, 복막자극증상 등
- Blumberg 징후: 압박한 손을 갑자기 떼면 보다 강한 통증을 느끼는 것
- 반발압통(rebound tenderness)라고도 함. 복막자극증상임
- 근육경직(muscular rigidity), 판상경직: 마찬가지로 복막자극 증상
- ㄱ 근육경직: 복벽을 가볍게 자극해도 근육수축이 일어나는 것
- ㄴ 판상경직: 근육경직이 계속되는 상태

5) 복부장기 이외의 질환:

- (1) 순환기 질환: 협심증·심근경색, 박리성 대동맥류, 대동맥류 파열, 장간막동맥 혈전증
- (2) 호흡기 질환: 폐렴
- (3) 내분비·대사 질환: 당뇨병, 요독증, 포르피린증
- (4) 기타: 납중독, 헤노흐셴라인 자색반, 결절성 다발동맥염, 대상포진, 가로막밑고름집
- (4) 기타: (횡격막하농양)

3. 한의학적 고찰: 치료 ☆

1) 기본치료혈

- 內關내관 支溝지구 照海조해 巨關거귄 足三里족삼리 天樞천추 大腸俞대장수 上巨虛*
* 상거허: 소화기 관련
- 陰谷음곡 陰陵泉음릉천 復溜부류 太谿태계 崑崙곤륜 行間행간 太白태백: 신장·간 관련
- 中脘중완 氣海기해 腎俞신수 膈谷합곡 三陰交삼음교

2) 변증치료

(1) 병인별 복통(육종복통(六種腹痛))

- ① 한복통(寒腹痛)
원인: 寒氣客於脾胃한기객어비위
증상: 卒然而痛졸연이통 線線痛而無增減선선통이무증감 得熱則感득열즉감
치법: 溫中散寒온중산한
치료혈: 神闕신귄(灸) 中脘중완

· ② 열복통(熱腹痛)

- 원인: 熱氣留於小腸열기류어소장(因積熱인적열)
- 증상: 時痛時止시통시지* 痛處亦熱통처역열* 手不可近수불가근* 便閉변폐 喜冷희냉
* 시통시지: 갑자기 통증이 있다 없어지기도 함
* 통처역열: 통처를 만져보면 열감이 있음
* 수불가근: 손을 가까이 가져가지 못하게 함
- 치법: 清熱通腑청열통부
- 치료혈: 陷谷함곡 膈谷합곡

· ③ 어혈복통(瘀血腹痛)

원인: 瘀血어혈(打撲타박, 墜墮추타, 婦人經來부인경래, 産後惡露未盡下而凝산후 오로미진하이음(산후오로가 있는데 다 나오지 못하고 어혈로 뭉쳐있는 것))

증상: 痛有常處而不移動통유상처이불이동* 臍下痛제하통 小便自利소변자리 大便黑 대변흑

* 통유상처이불이동: 항상 같은 곳에 통증이 있어 이동하지 않음

- 치법: 活血化瘀활혈화어

- 치료혈: 肝俞간수 膈俞격수 行間행간 血海혈해 三陰交삼음교 四滿사만

· ④ 식적복통(食積腹痛)

- 원인: 過食과식, 食滯식체

- 증상: 腹痛在上복통재상 痛甚欲大便통심욕대변* 利後痛感리후통감* 脈弦맥현

* 통심욕대변: 통증이 심하면 대변을 보고싶어 함

* 리후통감: 대변을 보고나면 통증이 경감

- 치법: 消食導滯소식도체

- 치료혈: 公孫공손 內庭내정(均瀉) 大腸俞대장수 足三里족삼리 上脘상완 中脘중완 天樞천추 胃俞위수

· ⑤ 담음복통(痰飲腹痛)

원인: 濕痰阻滯氣道습담조체기도

증상: 胸腹有聲흥복유성 小便不利소변불리 脈滑맥활

치법: 理氣豁痰이기활담

치료혈: 巨闕거궐 豐隆풍릉 上脘상완

· ⑥ 충복통(蟲腹痛)

원인: 蟲積충적

증상: 乍作乍止사작사지* 來去無定래거무정(痛處不定통처부정) 嘔吐清沫구토청말

* 사작사지: 때때로 통증이 생겼다 그쳤다 함

치법: 破積殺蟲파적살충 (기생충 제거)

(2) 허실별 복통

· ① 허복통(虛腹痛)

원인: 虛허, 寒한

증상: 按而不痛안이불통* 大便秘대변리 - 은은하게 오래된 통증들

* 안이불통: 만지는데 통증이 없고 오히려 편함

치법: 溫中止痛온중지통

· ② 실복통(實腹痛)

원인: 實실, 熱열, 積적

증상: 按之痛안지통 手不可近수불가근 大便堅대변건

→ +) 안지통: 만지면 통증이 있음 / 수불가근: 손도 못 대게 함 / 대변건: 대변 단단

치법: 清熱消積청열소적

(3) 부위별 복통

· ① 대복통(大腹痛)

원인: 食積식적, 外邪외사

부위: 胸骨以下흉골이하 臍以上제이상, 屬脾속비(太陰태음)

치법: 消積止痛소적지통

치료혈: 內關내관 合谷합곡 三陰交삼음교 足三里족삼리

· ② 제복통(臍腹痛)

원인: 積熱적열, 痰火담화

부위: 臍周圍제주위, 屬腎속신(少陰소음)

→ +) 배꼽 주위가 아픔 / 신장(소음)에 속하는 부위

치법: 清熱通裏청열통리

치료혈: 合谷합곡 內關내관 公孫공손 足三里족삼리 陰陵泉음릉천 太衝태충

足三里족삼리 支溝지구 中脘중완 關元관원 天樞천추 公孫공손 三陰交삼음교 陰谷음곡 獨陰독음

· ③ 소복통(小腹痛)

원인: 瘀血어혈, 痰담, 尿澀뇨삽

부위: 臍下제하, 屬肝속간(厥陰결음)

치법: 化瘀화어, 豁痰활담, 利尿이뇨

치료혈: 合谷합곡 內關내관 照海조해 太衝태충

✓ 요로계, 부인과 질환으로 많이 나타남

(4) 복통류증(腹痛類證)

· ① 적랭복통(積冷腹痛)

원인: 風寒濕犯胃풍한습범위

증상: 脾疼攻刺비동공자

치법: 祛風化濕거풍화습, 溫胃散寒온위산한

· ② 복통구설(腹痛嘔泄)

원인: 寒氣客於腸胃한기객어장위

증상: 腹痛복통 兼겸 嘔吐구토, 泄瀉설사

치법: 溫裏散寒온리산한

✓ 소아에게 이런 증상이 나타나면 전신감염 질환도 고려

ex) 뇌수막염 검사

▶케르니그(Kernig) 징후: 반듯이 눕혀놓고 무릎을 굽혀 90도로 만든 다음, 무릎을 펴려고 함 → 경추 쪽을 자극하게 됨

▶브루진스키 징후: 환자를 눕혀놓고 고개를 들게 함 → 뇌 경추 쪽 자극됨

· ③ 복중협착(腹中狹窄)

원인: 濕痰濁氣습담탁기, 攻於心脾공어심비, 升降失常승강실상

증상: 自覺腹中狹窄感자각복중협착감

치법: 健脾燥濕건비조습, 理氣割痰이기할담

· ④ 복피마비혹통(腹皮麻痺或痛)

원인: 腎虛不能行水신허불능행수, 酒麪過食주면과식*

* 주면과식: 음주하고 면을 너무 많이 먹었을 때

증상: 水滲於肚皮而作痛수삼어두피이작통*, 腹皮麻痺不仁복피마비불인*

* 수삼어두피이작통: 물이 두피 쪽으로 가 통증을 일으킴

복피마비불인: 복피가 마비감이 있으면서 느낌이 잘 안 느껴짐

치법: 消食導滯소식도체, 補腎行水보신행수

· ⑤ 복중명(腹中鳴)

원인: 中氣不足중기부족(脾胃虛비위허), 火水相擊화수상격

증상: 腹滿복만, 腸鳴장명

치법: 健脾養胃건비양위, 清利豁痰청리활담

치료혈: 下脘하완 陷谷함곡 公孫공손 足三里족삼리

✓ 위치에 따라

1. 腹濡鳴복유명: 胃俞위수

2. 腹中雷鳴복중뇌명, 大腸灌漑대장관비*: 大腸俞대장수(灸)

* 복중뇌명, 대장관비: 소리가 크게 들리고, 대장이 물 끓는 것처럼 안 좋음

3. 腹中腸鳴脇痛복중장명협통: 章門장문

4. 腹中腸鳴食不下복중장명식불하: 天樞천주

· ⑥ 용수증(湧水證) – 복중명의 증상 중 하나, 복중명보다 좀 더 심한 것. 소리가 남

원인: 肺移寒瘀腎폐이한어신

증상: 按之腹不堅안지복불건* 水氣客於大腸수기객어대장 疾行則鳴질행즉명*

* 안지복불건: 배를 만져보면 단단하지는 않음

질행즉명: 빠르게 움직이니 소리가 남

- 치법: 散寒行水산한행수

3) 기타치료혈

· ① 복중절통(腹中切痛)*: 公孫공손 습곡합곡 太衝태충

* 복중절통: 끊어지는 것 같은 통증

· ② 복중통(腹中痛), 당설(滯泄): 神闕신궐(隔灸격구) 氣海기해(灸)

· ③ 복적통(腹積痛): 氣海기해 中脘중완 隱白은백 太衝태충

· ④ 기체복통(氣滯腹痛): 氣海기해 內庭내정 太衝태충(均瀉)

· ⑤ 혈허복통(血虛腹痛): 膈俞격수 三陰交삼음교(均補)

· ⑥ 기허복통(氣虛腹痛): 關元관원 氣海기해 中脘중완(均灸)

✓ 복통의 여러 원인

· 1) 소화기 질환 (가장 多): 위, 장(대장, 소장) → 복통 부위가 다르게 나타남

위: 상복부(중완, 상완 부위) 통증

소장: 배꼽 바로 윗부분의 불편감

췌장: 식후복통(밥 먹고 나면 갑자기 배가 아프고 화장실 가고 싶고, 대변을 보고 나면 좀 편해짐) 췌액*분비가 잘 안 되면 위산의 산 성분이 장을 자극하기 때문. 따라서 대변을 봐서 물질이 배출되면 통증이 가라앉음

· 2) 부인과 질환(난소, 자궁)도 염두에 두기: 하복부